

6 - 02.1- Fractures mandibulaires - Pr. Mansouri

(0:01 - 0:38)

Très bien, donc les fractures mandibulaires, pour nous en chirurgie maxillofaciale, c'est l'urgence la plus fréquente en chirurgie maxillofaciale, comme les fractures de la jambe, comme les fractures supracondyliennes chez l'enfant. Toujours pour les mêmes raisons, comme l'appelait, c'est l'agression dans 35% des cas, c'est les accidents de la voie publique dans 75% des cas, nous avons les accidents de la voie publique et nous avons l'agression. Les fractures sont des lésions de l'os mandibulaire qui regroupent les fractures de la portion dentée et la portion rétrodentée.

(0:39 - 1:01)

Dès maintenant, on va considérer deux parties de la mandibule. Celle qui porte les dents, il y a la partie du corps, la fièvre ciné, et c'est dit d'emblée des fractures ouvertes, même si elles ne sont pas ouvertes. Parce que quand l'os est cassé, à cause de la muqueuse et des dents, il est en communication avec la cavité buccale, exactement comme une plaie de la muqueuse.

(1:02 - 1:24)

Et donc ce sont des fractures, des ressemblances antibiotiques, pas des fractures ouvertes des jambes. Et nous avons celles qui sont rétrodentées, les muscles, elles sont fermées. Elles sont problématiques parce qu'elles peuvent être responsables du non-kylose temporomandibulaire, ça veut dire que l'articulation va coller et l'être humain ne va plus pouvoir ouvrir ses dents.

(1:25 - 1:34)

Radiation liquide. Plus possible d'ouvrir la bouche. Elles peuvent aussi, quand elles surviennent chez l'enfant, créer des troubles de la croissance.

(1:35 - 1:57)

Un enfant de 7 ans, s'il a le malheur d'avoir une fracture condylienne, qui est le centre actif de la croissance, c'est lui pour son visage, il va être dysmorphique. Parce qu'il ne finit la croissance de la mandibule jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc la fracture va empêcher la mandibule de descendre, donc il aura un visage en profil d'oiseau.

(1:58 - 2:18)

Le maxillaire qui avance et la mandibule qui recule. Le diagnostic, il est clinique et il est confirmé par une seule radio, c'est l'orthopantomogramme ou bien la radio panoramique. Si je pose un QCM, quelle est l'exploration utile dans les fractures mandibulaires ? Orthopantomogramme.

(2:18 - 2:51)

Est-ce que c'est clair ? Mais chez le scanner, orthopantomogramme, sauf bien sûr qu'il y a des contre-indications, il a calomnié, il ne peut pas s'asseoir ou là il est comateux, mais s'il est bien conscient, la radio panoramique. Malgré l'arrivée du scanner, malgré l'arrivée de toutes les explorations, c'est la radio panoramique, qui est une radio standard, qui reste le gold standard dans le diagnostic. Le traitement peut être chirurgical, fonctionnel, et dans tous les cas, il est fonctionnel, parce que c'est une articulation qui bouge comme le genou, comme le coude.

(2:52 - 3:08)

Tu opères, il faut faire la rééducation et l'alimentation liquide. Donc le traitement fonctionnel, il est toujours de mise, mais il y a le traitement chirurgical, bien sûr, qui peut être soit orthopédique, soit avec des plaques. La prévention, elle est de mise, bien sûr.

(3:08 - 3:33)

Quand on voit que 70% de nos fractures sont liées aux accidents de la voie publique et à l'agression, on a le châtelet raciale qui s'arrête. Je vais en Suisse, qui dit qu'il y a un chauffeur à quatre heures du mois, et on voit un chauffeur dans la nuit, dans la nuit, c'est la dernière chose. Vous avez compris ? Il n'y a pas de chauffeur à quatre heures du mois, et on voit un chauffeur dans la nuit, dans les périodes piques.

(3:33 - 3:44)

Dans la nuit, il y a deux, trois, quatre. Ce n'est pas des jambes, ce n'est pas des membres, c'est le visage, le visage, les hijabs. Normalement, on se protège pour ne pas recevoir de coups.

(3:44 - 3:52)

C'est une farce. Nous sommes des champions dans le monde, dans la fracturologie faciale. C'est malheureux, à Marrakech.

(3:53 - 4:17)

C'est malheureux parce que c'est trop. Dans le monde, il n'y a pas de boxe de maxillo-faciales pour les urgences. Le maxillo, normalement, c'est... On a trois résidents, un interne et un externe, qui fait la garde dans le service? Est-ce qu'il y a un externe dans le service parmi vous? Non, il n'y a personne.

(4:18 - 4:38)

Vous, vous avez fait la garde? Ce n'est pas normal. Le jour où j'ai été affecté dans cette faculté, j'ai crié, j'ai hurlé à quelqu'un de me donner des résidents et de me donner des boxes aux

urgences. Ce que j'ai vu dans cette ville, j'ai été à l'étranger, je ne l'ai jamais vu quelque part dans le monde.

(4:39 - 4:47)

Donc, malheureusement, je dois former des médecins généralistes qui savent suturer les faces. Parce que nous, on ne peut pas tout suturer au CHE. Vous devez tout faire chez vous.

(4:48 - 5:01)

Là où vous êtes affecté, vous vous trouvez, vous devez assurer la suture. Si on va passer la nuit à passer 150 plaies par nuit, vous avez failli l'avoir. D'ailleurs, nous sommes très contents parce qu'aujourd'hui, les élèves de la faculté de médecine, ils sont nombreux, la fac a diplômé 2000 médecins.

(5:01 - 5:12)

Tous les urgentistes généralistes issus de cette faculté suturent les plaies dans les cliniques, dans les hôpitaux périphériques, partout. Il y a une pluie comme une pandémie. C'est comme une épidémie.

(5:17 - 5:31)

Vous savez que Marrakech est caractéristique par ses motos et ses bicyclettes. Et bien sûr, tout le monde met le casque, que ce soit les motocycles moteurs ou les bicyclettes. Pas de casque.

(5:31 - 5:38)

Et donc, toute chute est une plaie. Ou bien une fracture de la face. C'est tout.

(5:39 - 5:46)

Nous sommes les deux. D'ailleurs, quand on a publié nos publications, la seule ville qui écrit comme nous, c'est la seule ville de l'Indonésie. C'est tout.

(5:49 - 6:04)

C'est les villes où se trouve le transport par moto, cycle, où il y a beaucoup d'accidents, bien sûr. Bien sûr, il y a autre chose ici. C'est qu'on est au Maroc profond et les gens sont fiers.

(6:08 - 6:23)

Il est fier. Il met la ceinture pour sa sécurité personnelle. Il est fier.

(6:24 - 6:45)

Alors qu'il est tout le temps en train de conduire, mettez la ceinture s'il vous plaît. Il doit être plus prudent que tout le monde. Vous comprenez ? Le non-port de la ceinture de sécurité égale des fractures de la face et des pare-brise et des plaies de la face parce que devant tout coup de frein à frein, la face se projette vers le pare-brise et on a des dégâts incontestables.

(6:46 - 7:05)

On a des polytraumatismes de la face. Et donc, la fracture mandibulaire s'intègre dans ce processus. Vous vous faites des gardes aux urgences et vous savez, c'est la jeunesse, c'est la pauvreté, c'est le profil social, c'est la toxicomanie, c'est ça.

(7:05 - 7:13)

Il y a beaucoup d'agressions. Il y a l'agression de la femme par le mari, de l'ami par l'ami, de l'homme à l'homme, la femme à la femme. On a tout vu.

(7:14 - 7:22)

La femme qui se met à agresser ses enfants. L'agression, elle est à un niveau très, très élevé à Marrakech. On ne le dit pas.

(7:22 - 7:30)

On est une ville de tourisme. Mais nous, on est en train de faire ça. Nous devons le savoir et nous devons nous assurer de la prévention.

(7:30 - 7:38)

Nous devons sensibiliser la population. Nous devons sensibiliser les jeunes. Sensibiliser la sécurité civile, bien sûr.

(7:39 - 7:51)

C'est pour cela que je mets ici prévention ciblée, diagnostic précoce, bien sûr, et un traitement adéquat. Donc, il y a les objectifs éducationnels. Il y a le rappel de l'anatomie.

(7:52 - 8:04)

Vous savez que la mandibule, elle comporte un corps qui porte des dents et un rameau, une branche montante où il n'y a pas de dents. On l'a dit déjà. Vous avez donc le coroné là en haut.

(8:04 - 8:14)

Vous avez le condyle. Si vous vous rappelez, en anatomie, on a eu ça. La branche montante, le corps, la partie alvéolaire et la sortie du nerf dentaire.

(8:15 - 8:25)

Cette subdivision fait les formes cliniques. Après, topographique. Après, on va voir les fractures du coroné, les fractures du condyle, les fractures de la branche montante et les fractures de langue.

(8:25 - 8:45)

Ça, c'est la partie rétrodentée. Et puis, nous avons les fractures de la région symphysaire en avant de la canine et les fractures de la région branche horizontale qui sont entre la canine et la dent de sagesse. Ça, c'est la subdivision anatomique que nous allons voir après dans la subdivision des formes topographiques.

(8:46 - 9:07)

Quelle est la particularité de cette osse quand tous les os du corps la traversent d'un nerf ? Il y a un nerf qui le traverse, c'est le nerf mandibulaire. C'est-à-dire, quand il y a une fracture, la nécessité de chercher une hypoesthésie qui est médico-légale. Et donc, vous voyez que le nerf, il sort à côté de la canine.

(9:07 - 9:29)

Donc, toutes les fractures qui sont devant la canine ne comportent pas d'hypoesthésie labio-montonnière. Et toutes les fractures qui sont derrière le trou de la canine, donc l'orifice montonnier, tout ce qui est derrière va entraîner une hypoesthésie labio-montonnière. L'épidémiologie, elle est intéressante.

(9:29 - 9:36)

J'ai vu ce mec, j'ai mis cette photo. Donc, c'est très fréquent. C'est le jeûne, c'est l'agression, c'est les accidents de la voie publique.

(9:37 - 9:48)

Parce que, moi, je vous fais l'épidémiologie, vous me demandez si je fais l'épidémiologie. Oui, l'épidémiologie, c'est le miroir du pays. Si j'enseigne à Paris, je ne vais pas afficher la même plaque.

(9:49 - 10:00)

Est-ce que je vais mettre les agressions et les accidents de la voie publique ? Non. Je vais mettre les accidents de sport et les accidents de travail. Maintenant, les accidents de la voie publique sont minoritaires.

(10:00 - 10:11)

Maintenant, les agressions sont minoritaires. Vous me demandez les accidents de travail, la protection sur les lieux de travail. Les jeunes font beaucoup de sport.

(10:11 - 10:16)

Nous, on ne fait pas beaucoup de sport. Vous le savez, bien sûr. Entre autres, les étudiants en médecine.

(10:16 - 10:31)

Il devient sportif, alors qu'il est dans la fac de médecine. Il devient sportif de Powerpoint, sportif des références de cours, mais il quitte le sport. Par exemple, nous, on n'est pas un peuple sportif, donc on n'a pas beaucoup d'accidents de sport.

(10:32 - 10:46)

Vous voyez, l'épidémiologie, c'est le miroir de ce qui se passe. Quand j'ai enseigné à vos professeurs, quand je suis arrivé de l'étranger, j'ai mis cette pathologie. Les fractures mandibulaires sont très fréquentes dans les accidents de sport et de travail.

(10:47 - 11:12)

Je me suis mise à travailler à Marrakech, et j'ai trouvé que c'est l'agression et les accidents de la voie publique. Et donc, j'ai changé de vision. Donc, qu'est-ce qu'est l'examen clinique d'une fracture mandibulaire suspecte ? C'est l'examen d'un traumatisé, éliminer une urgence vitale, un traitement prioritaire, et puis après, faire un examen maxillofacial.

(11:12 - 11:18)

Moi, je crois que je vais vous laisser comme c'est promis, à moins de 10, pour que vous vous reposiez un petit peu, et à la prochaine.